

に寄与しうる肺胞中隔（胞隔）のことを指す）, 「広義の間質」(小葉間結合組織, 胸膜の結合組織, 気管支・肺動脈周囲結合組織など, ガス交換には直接関与しない支持体) (図8), および, 「病的間質」をすべて「間質」という用語で呼ぶからである。

間質性肺炎の場合, 狭義の間質（胞隔）に炎症性細胞浸潤（細胞性胞隔炎）や線維化（膠原線維の増加）が生じるばかりではなく, しばしば肺胞腔内の器質化物が胞隔に付着し（壁在性器質化・線維化）, 解剖学的な胞隔と一体化（胞隔への組み込み）してガス交換に寄与しえない病的な間質が形成される, あるいは, 一定の領域の肺胞が虚脱・癒合して病的な間質ができ

る（無気肺や肺胞の畳み込みなど）ことがむしろ本質的病変である。これらの病的「間質」の両隣には空気の入っている肺胞腔があるから, ここに「空気のあるところ」, 「(病的に) 空気のないところ」, 「空気のあるところ」という新たな繰り返し構造が生じ, 「(病的に) 空気のないところ」を「間質」と呼ぶことになる。その結果, 実際の病的現象は腔内反応や肺胞虚脱であるにもかかわらず, 「間質」が病変の座であるという表現のすれ違いが生ずる。このことは間質性肺炎の本質的理解を困難にしている一因でもある。

間質性肺炎・肺線維症とは, 「間質」に炎症や線維化が起きている疾患」ではなく「ガス交換に寄与しえない“病的間質ができる”疾患」と捉えておかないと画像と病理所見とに乖離が生じてしまう⁶⁾。

5 小葉と細葉

肺疾患の画像診断はCT（特にHRCT）の登場によって著しく進歩し, 精密な診断が行われている。肺疾患, 特にびまん性肺疾患のHRCT診断では, 病変は肺小葉との関係で論じられ, 記述される。肺小葉（細葉）は肺の機能的単位と考えられるとともに胸部CT診断の基盤となる肺の構造単位でもある。

小葉（lobulus）の定義は提唱者によって若干異なるが, 解剖学的にわかりやすいのは小葉間隔壁（interlobular septum; 小葉間間質）によって囲まれた1 cm 四方程度の領域, すなわち Miller の二次小葉（secondary lobulus）である（図8, 図9）。

間質性肺炎の診断基準などで, 単に小葉と表現されているのは多くの場合 Miller の二次小葉であって,

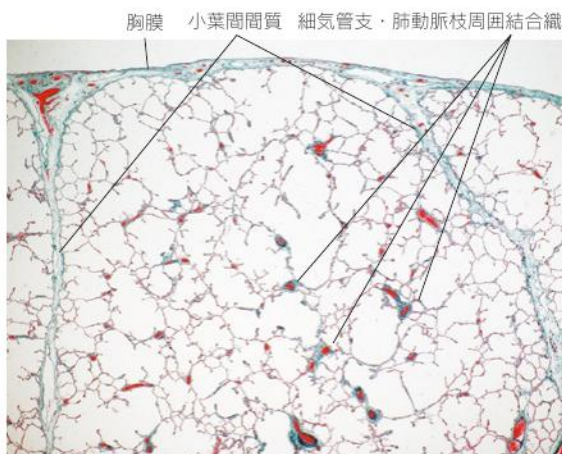


図8 広義の間質（弾性線維染色, EMG 染色）
胸膜, 小葉間間質, (細) 気管支・肺動脈枝周囲結合組織（気管支血管束）などが広義の間質である



図9 小葉（Miller の二次小葉）の実体顕微鏡像（肉眼像）
胸膜と小葉間間質に囲まれた領域が小葉である。二次元の面では小葉（細葉）中心部は現れないことがある。組織像は図8を参照。